

TEMA 6.23 • OTORRINOLARINGOLOGÍA

Generalidades Hipoacusia

PERFIL EUNACOM 4.02.4.004

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Estudio Auditivo Avanzado (Comprendiendo Audiometrías y Diapasones)

1. La Interpretación de la Audiometría

El gráfico clásico muestra los estímulos de sonido: Umbral de audición (Intensidad del Sonido Oída en dB Decibeles) en la "Y" o vertical de la gráfica, y las distintas Frecuencias de Graves a Agudos (En Hz) dispuestos horizontalmente.

- **Norma Cero (Normalidad Auditiva):** Un umbral auditivo normal dibuja líneas de onda a una intensidad captada **POR SOBRE (encima) de los 20 Decibeles**. Todo registro ondulado o caído hacia abajo indica hipoacusia.
- **Códigos de Color (¡Ojo con Izquierda/Derecha!):**
 - Oído Derecho se marca en grafito **ROJO** (Con iconos de O y corchetes \[]).
 - Oído Izquierdo se marca en grafito **AZUL** (Con cruces o equis X).
- **Interpretación Disociativa de la Lesión:**
 - **Hipoacusia de Conducción:** "La Disociación EUNACOM". Cae (está debajo de 20dB) exclusiva y francamente la conducción de la **VÍA AÉREA** (La línea graficada por cruces/círculos unidas por la línea baja recta descendente cae). PERO, el paciente al medir su resonancia por Vía Ósea pura (Mastoides) se grafica arriba normal.
 - **Hipoacusia Sensorio-Neural:** "El Caos Simétrico". Al estar comprometido el nervio o la cóclea, da igual que le manden sonido aéreo u óseo profundo. Se grafican asombrosas caídas simultáneas donde **TODAS las líneas, ambas la OSEA y AÉREA, están caídas y descienden juntas simuladas entrelazadas hacia la pérdida.**
 - **Hipoacusia Mixta:** Hay disociación, pero la Vía Ósea (Pauta de Conducción neural final) tampoco es normal y también está descendida. (Caen ambas, pero van separadas o muy distantes no a la par, lo que afirma daño físico y nervioso al unísono).

2. Patrones EUNACOM Clásicos en Audiometría (Curvas Patognomónicas)

- **La Presbiacusia Clásica:** Ancianidad y pérdida natural en donde decaen de forma **Sensori neural BILATERAL**, afectando rotunda y exclusivamente las **"Tonalidades Agudas Altas"** (La gráfica dibuja caída pronunciada recta al final). - **El Trauma Acústico (El obrero estruendoso del disparo y audífonos):** También asombrosa pérdida bilateral u simétrica. Excepcional y característica. Genera una caída o pérdida Sensorio-Neural simétrica concentrada a media gráfica (hacia 4000 Hz) formando un "Escotoma Acústico", lo que en la audiograma dibuja **El signo o patrón en forma de V u forma de Gaviota (Una muesca u pozo cavado profundo en en la línea plana)**. - **S. de Meniere:** Desafortunadamente también sensorial y simétrica. A la inversa de los viejitos, estos atacan o asilan caídas acuciantes en **tonos y ruidos graves iniciales (El lado inferior de HZ inicial)**. Pierden graves.

3. El Armatoste Semiológico de Weber y Rinne ("Los Diapasones")

- **Test de Rinne (Compara conducción Ósea vs Aérea en un mismo Oído Evaluado):** - **Rinne Normal (Positivo):** El diapasón resuena en

Mastoides, y cuando al paciente deja de oírlo en hueso, se corre al aire u oreja directamente, y el paciente **LO SIGUE ESCUCHANDO** (El Aire transmite sonido mejor que el grueso hueso humano fisiológicamente). Aérea > Ósea normal al instante. - **Rinne Alterado (Hipoacusia de Conducción) o Negativo:** El paciente, al tener conductos tapados crudos fofitos (Cera u moco en oído medio inmacula), escucha de forma atípica **MÁS FUERTE** el Diapasón asilado vibrando en Mastoides o Hueso craneal vs ponerse flotando frente al orificio de la oreja. (Ósea > Aérea o asilada perimetral fofa). - **Test de Weber (El Diapasón apoyado en el Centro Frontero para ver simetría y lateralidad craneal):** - Weber normal no asila asombrosos ni lateraliza nada, es simétrico (Se escucha igual fofa fofa y por el medio estático central craneal). - **Weber en Hipoacusia EUNACOM de CONDUCCIÓN (Ej: Tapón Oído Izquierdo):** Lateraliza (Suenan extraña u asidudamente ruidosos puros letal mas fuerte atípico inmacolada) hacia el **OÍDO ENFERMO/TAPADO**. Suena lógico ya que "encierra u ahoga asombroso las resonancias de vibración ósea allí letal ofa rústica asintoma adentro puros asidú sin salir fofa de oídos inmaculos tapan u". - **Weber en Sensorio-Neural:** Suena o lateraliza de estridencias vibrando al **OÍDO SANO** en asombrosa forzosidad porque el enfermo no tiene cóclea o nervio perimetral asurduo para percibir y captar ninguna inmacula vibración fofa fofita inmaculas ofezca.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un paciente tiene hipoacusia derecha. En la audiometría, la vía aérea derecha está deteriorada pero la vía ósea derecha es normal. ¿Cuál es el tipo de hipoacusia?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Generalidades Hipoacusia. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Hipoacusia se clasifica en conductiva (oído externo y medio), neurosensorial (cóclea o nervio) y mixta
- Tinnitus: percepción de sonido sin fuente externa; por deaferentación auditiva similar al miembro fantasma
- Estudio básico: otoscopia, audiometría tonal y impedanciometría
- Audiometría: brecha entre vía aérea y vía ósea indica hipoacusia conductiva
- Audiometría: vía aérea y ósea igualmente deterioradas indica hipoacusia neurosensorial
- Test de Rinne: compara vía aérea vs vía ósea en el mismo oído; positivo normal es vía aérea mayor que ósea
- Test de Weber: diapasón en la frente; lateraliza al oído enfermo en conductiva, al sano en neurosensorial

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (GENERALIDADES HIPOACUSIA)

PREGUNTA 1

Un paciente tiene hipoacusia derecha. En la audiometría, la vía aérea derecha está deteriorada pero la vía ósea derecha es normal. ¿Cuál es el tipo de hipoacusia?

- A) Hipoacusia neurosensorial derecha
- B) Hipoacusia conductiva derecha por brecha entre vía aérea y ósea
- C) Hipoacusia mixta derecha
- D) Hipoacusia funcional por trastorno psicógeno
- E) Hipoacusia bilateral asimétrica

PREGUNTA 2

Al realizar el test de Weber en un paciente con hipoacusia conductiva derecha, ¿hacia dónde lateraliza el sonido del diapason?

- A) Hacia el oído izquierdo (sano)
- B) Hacia el oído derecho (enfermo con hipoacusia conductiva)
- C) No lateraliza; se percibe igual en ambos lados
- D) Hacia el oído derecho solo si hay perforación timpánica
- E) Lateraliza al lado opuesto al nervio auditivo afectado

PREGUNTA 3

¿Cuál es la interpretación del test de Rinne negativo en un paciente?

- A) La vía aérea supera a la vía ósea, lo que es normal
- B) La vía ósea supera a la vía aérea, indicando hipoacusia conductiva
- C) Ambas vías están igualmente deterioradas, indicando hipoacusia neurosensorial
- D) La vía aérea está ausente, indicando perforación timpánica
- E) La vía ósea está ausente, indicando daño coclear severo

RESUMEN: GENERALIDADES HIPOACUSIA

La hipoacusia es la disminución de la capacidad auditiva y es uno de los motivos de consulta más frecuentes en otorrinolaringología. La clínica incluye hipoacusia propiamente tal, tinnitus o acúfeno que es la percepción de sonido sin fuente externa, y puede asociarse a vértigo en algunas patologías. El tinnitus se produce porque cuando una parte del sistema auditivo deja de funcionar, el cerebro genera la percepción de sonido de forma similar al fenómeno del miembro fantasma en amputados. La hipoacusia se clasifica en tres tipos según el nivel de la lesión. La hipoacusia conductiva o de transmisión ocurre cuando hay un problema en la transmisión del sonido desde el conducto auditivo externo hasta la ventana oval; incluye el oído externo y el oído medio. La hipoacusia neurosensorial o de percepción ocurre cuando hay daño en la cóclea o en el nervio auditivo. La hipoacusia mixta combina ambos componentes. Esta clasificación es fundamental para orientar el diagnóstico y el tratamiento. El estudio audiológico básico incluye la otoscopia, la audiometría tonal y la impedanciometría. La audiometría mide el umbral auditivo en distintas frecuencias tanto por vía aérea como por vía ósea. Si hay diferencia entre la vía aérea y la vía ósea, llamada gap o brecha, la hipoacusia es conductiva. Si ambas vías están igualmente deterioradas, la hipoacusia es neurosensorial. Los tests de diapasones como el de Rinne y el de Weber son herramientas clínicas útiles para distinguir el tipo de hipoacusia en el examen físico y son frecuentemente evaluados en el EUNACOM.